

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA

Jésica Rodríguez Álvarez, Javier Sánchez Palacios, Ana Belén Vega López, Maria Soledad Medina Martos.

INTRODUCCIÓN

La parálisis facial periférica es un cuadro frecuente de causas multifactoriales, por lo general es de causa benigna. El VII par craneal es un nervio mixto, con fibras motoras (músculos hemicara, platisma, vientre posterior del digástrico y estilohioideo), fibras sensitivas (área de Ramsey-Hunt), fibras vegetativas viscerales (gl. nasales, lacrimales, submaxilar y sublingual) y fibras sensoriales (sensibilidad gustativa 2/3 anteriores de la hemilengua homolateral).

Clasificación según localización:

- **Parálisis facial central:** se trata de una parálisis de la hemicara inferior contralateral (queda excluida musculatura frontal)
- **Parálisis facial periférica:** es una parálisis completa de toda la cara homolateral. Dentro de ésta se puede clasificar a su vez en idiopática o de Bell (70%), traumática (2º causa más frecuente), tumoral.

<u>Parálisis facial periférica</u>	<u>Parálisis facial central</u>
• Asimetría facial • Incapaz de elevar la ceja y cerrar el ojo • Signo o fenómeno de Bell presente • Desviación de la comisura bucal hacia el lado sano	• Función conservada de los músculos de la frente y párpado superior • Signo o fenómeno de Bell ausente • Generalmente presenta parálisis ipsilateral

Sospecha de parálisis facial no idiopática

- Que se produzca de forma gradual (semanas o meses)
- Afectación bilateral
- Episodios recurrentes.

DIAGNÓSTICO

Clínico

Importante realizar una buena anamnesis y una buena exploración física.

- **Anamnesis** preguntar por:
 - Antecedentes de TCE
 - Forma de instauración (si aguda, si bilateral).
 - Tiempo de evolución.
 - Antecedentes de infección.
 - Episodios similares.
- **Exploración física:**
 - General: constantes básicas. Exploración otorrinolaringológica básica (valorar oído, nariz y garganta) y otoscopia.
 - Neurológica: Debemos valorar los distintos músculos inervados por el nervio facial buscando posibles asimetrías.
 - Alteraciones propias de la afectación del VIII par craneal:
 - MOTORAS: asimetría facial, hemicara inexpresiva con desaparición de pliegues

frontales y nasogenianos homolaterales, signo de Bell, desviación de la comisura labial hacia el lado sano.

- SENSITIVAS: molestias oculares con alteraciones de la secreción lacrimal, parestesias en cara, algeusia, otalgia, algiacusia. El dolor no está relacionado con el grado de severidad de la parálisis.
- **Pruebas complementarias:**
 - Hemograma.
 - Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, amilasa, PCR.
 - Coagulación básica.
 - TAC craneal: si sospecha de parálisis facial no idiopática o patología neurológica acompañante.

TRATAMIENTO

- **Cuidados oculares** (lagrimas artificiales para evitar sequedad de córnea, parches oculares nocturnos).
- Evitar en la fase aguda ejercicios que impliquen musculatura facial (ej: comer chicles) ya que pueden provocar una mayor asimetría al igual que facilita la aparición de sincinesias.
- **Prednisona a 1mg/Kg/día** hasta un máximo de 60-80mg durante una semana y posterior disminuir gradualmente durante otra semana. Dentro en las primeras 48h después del inicio, presentan mejor recuperación más rápida y más completa.
- Si sospecha de infección por herpes:
 - **Aciclovir 200 mg** 1 cada 4 horas durante 5 días vía oral o
 - **Fanciclovir 500mg** 1 cada 8 horas durante 7 días vía oral o
 - **Valaciclovir 1 gr** 1 cada 8 horas durante 7 a 10 días vía oral.
- Suele tener una evolución clínica favorable y se resuelve ad integrum y sin necesidad de tratamiento en un 70% de los casos. El 30% restante podrá tener secuelas leves o graves.

BIBLIOGRAFÍA

- Bernard C. Kinesiterapia de las parálisis faciales. EMC-Kinesiterapia- Medicina física 2013; 34 (4): 1-11. [Artículo E-26-463-B-10].
- Balaguer García R, Casaña Pérez S., Suárez-Varela M.M, Escudero Torella M., Dalmau Galofre J. Secuelas de las parálisis faciales periféricas. Acta otorrinolaringológica española, 2010; 61 (2): 89-93.
- Teixeira L.J, Valbuza J.S, Physical therapy for Bell's palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2008; (12; Art N. O CD006283).
- Sullivan, F. M, Swan I.R, Donnan P.T, Morrison J.M, Smith B. H, Mckinstry B, et al. Early treatment with prednisolone or acyclovir in Bell's palsy. N Engl J Med, 2007; 357: 1598-1607.

HOMBRO CONGELADO O CAPSULITIS ADHESIVA

Jésica Rodríguez Álvarez, Javier Sánchez Palacios, José Ramón García Zarza, María Soledad Medina Martos.

INTRODUCCIÓN

Inflamación fibrosante de la articulación glenohumeral que produce una limitación del balance articular de forma activa y característicamente de forma pasiva. Es típica de mujeres en torno a los 50-60 años. Tiene una prevalencia de entre el 2-5%. Consta de tres fases: una primera fase que se caracteriza por dolor, una segunda fase que se caracteriza por rigidez y una tercera en la que se produce la resolución.

Clasificación:

- Primaria: no se encuentra ningún factor que incite la aparición de la misma.
- Secundaria: en casos de rigidez postraumática, asociada a DM o alteraciones tiroideas, traumatismos, entre otras.

DIAGNÓSTICO

Clínico basado en la exploración física

Exploración Física:

- Omalgia de características inflamatorias que no cede con el reposo.
- Alodinia o dolor por estimulación táctil que en condiciones normales no debería ser dolorosa.
- Limitación de todos los ejes del movimiento especialmente en la rotación externa tanto de forma activa como de forma pasiva, presentando en ésta última un tope característico. Esto es muy importante ya que nos permite diferenciarlo de otras patologías frecuentes del hombro como por ejemplo pudiera ser una rotura del manguito rotador.

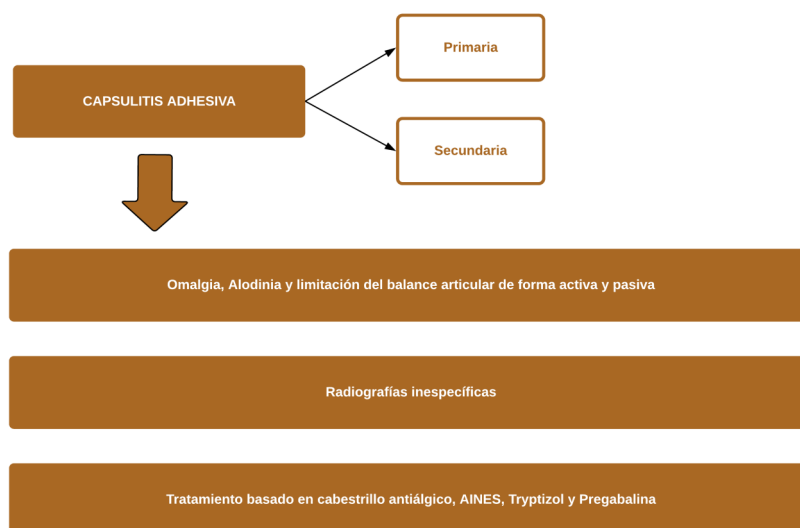
Se debe hacer un **diagnóstico diferencial** con el hombro rígido postraumático en el cual también existe una limitación con mayor afectación en la rotación interna

Pruebas Complementarias:

- Radiografía de hombro: es típicamente normal, pudiéndose observar en algunos casos desmineralización ósea.

TRATAMIENTO

- Colocación de cabestrillo antiálgico, evitando así la inmovilización del mismo.
- AINES según patología adyacente del paciente.
- Tryptizol 50mg preferentemente antes de acostarse, pudiendo aumentar dosis hasta 150mg/día.
- Pregabalina.
- Derivación al servicio de rehabilitación de forma preferente.



BIBLIOGRAFÍA

- Chassunot et Quesnot. Rehabilitación del miembro superior. España: editorial Panamericana, 2010.
- Serrano AM, Abush S. Capsulitis Adhesiva. Anales médicos. 2017; Vol. 62(1): 37-43.
- Dudkiewicz I, Oran A, Salai M, Palti R, Pritsch M. Idiopathic adhesive capsulitis: longterm results of conservative treatment. Isr Med Assoc J. 2004; 6: 524-526.

LINFANGITIS

Jésica Rodríguez Álvarez. Javier Sanchez Palacios. Joaquin Rodríguez Prieto. Asunción Garcia Alonso, Maria Soledad Medina Martos.

INTRODUCCIÓN

Se trata de una infección primaria local de los vasos linfáticos superficiales producida por la flora autóctona de la piel, sin afectación sistémica. Se produce típicamente por estreptococos del grupo A, aunque puede producirse por otros microorganismos.

Es la complicación más frecuente en pacientes con linfedema pudiendo llegar a afectar hasta a un 40% de los mismos.

Clasificación:

- **Primaria:** Puede denominarse linfangitis o erisipela, diferenciándose ésta última de la anterior en que puede ser contagiosa y que tiene afectación/ reacción sistémica.
- **Secundaria** o dermatolinfangioadenitis: afectación de la hipodermis y tejido celular subcutáneo por la flora microbiana ambiente. Alta tendencia a la recurrencia.

DIAGNÓSTICO

Clínico

Dolor, aumento del edema y eritema de inicio rápido, en cuestión de horas. Suele tener un factor desencadenante previo como puede ser un traumatismo o una picadura. Si se acompaña de vesículas, linforragia, fiebre o vómitos lo catalogaríamos de grave.

Se debe hacer un diagnóstico diferencial con tromboflebitis superficial y TVP, dermatitis de contacto, micosis y eczema venoso.

Pruebas Complementarias

- Analítica sanguínea: Hemograma con formula leucocitaria. Bioquímica básica y coagulación. Importante valorar VSG, PCR, PCT y leucocitosis.

TRATAMIENTO

- Reposo y elevación del miembro afecto.
- Retirar prenda de compresión durante el episodio. Volver a colocar una vez el episodio cese.
- Evitar autodrenaje o drenaje linfático.

Penicilina G Benzatina 1.200.000 im, en dosis única que se pondrá de forma

+

1ª elección: Amoxicilina-Clavulánico 875/125mg cada 8 horas durante 15 días.

2ª elección: Cloxacilina 500mg cada 6 horas durante 15 días.

En alérgicos a penicilina:

1ª elección: Eritromicina 500mg c/8h o Claritromicina 500mg c/12h 15 días.

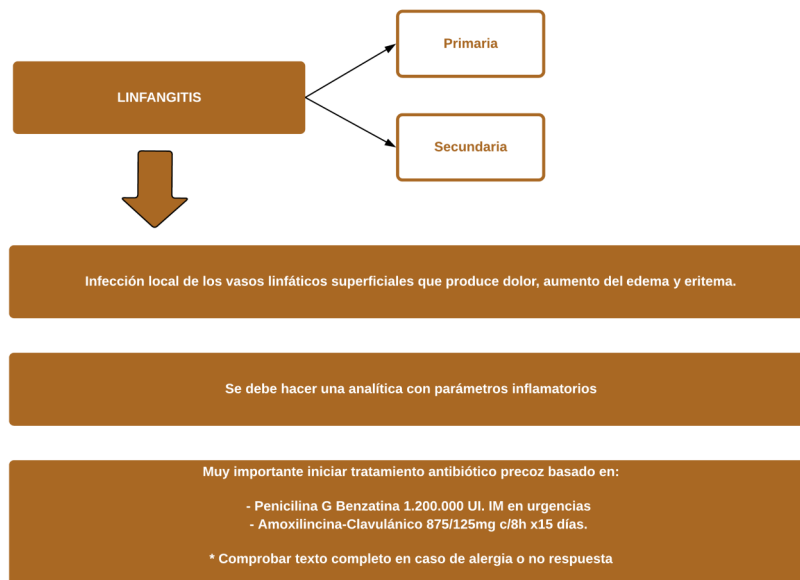
2ª elección: Ciprofloxacino 750mg c/12 horas durante 10 días.

Si tras 48 horas no se produce mejoría y vuelve a acudir a urgencias: Cefazolina 1g c/8h iv.

- Tratamiento antibiótico precoz basado en:
- Se pueden asociar paracetamol para el dolor. Los AINES **no están recomendados** por

riesgo de fascitis necrotizante.

- Derivar al servicio de Rehabilitación de forma preferente.
- Se debe valorar el ingreso hospitalario en casos de: sospecha de septicemia, signos de afectación sistémica persistentes tras 48h de tratamiento o persistencia de los signos locales a pesar del uso de la primera y segunda línea de tratamiento.



BIBLIOGRAFÍA

- Olszewski WI. Infection. in: lee BB, Bergan J, Rockson SG, editors. Lymphedema: a concise compendium of theory and practice. London: Springer Verlag London limited; 2011. p. 207-216.
- Guía de práctica clínica. Orientación diagnóstica y terapéutica del Linfedema. Puigdemívol Serafí C. (coord) y Alonso Álvarez B. (coord). 2017: 39-44.
- UK dermatology clinical trials network's patch trial team, Thomas K, Crook A, Foster K, Mason J, Chalmers J, et al. Prophylactic antibiotics for the prevention of cellulitis (erysipelas) of the leg: results of the UK dermatology clinical trials network's PATCH II trial. Br J dermatol. 2012;166(1):169-78.

SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO, DISTROFIA SIMPÁTICO REFLEJA O SUDECK

Jésica Rodríguez Álvarez, Sonia Ruth Navarro Prada, Maria Soledad Medina Martos.

INTRODUCCIÓN

Dolor difuso, de predominio distal, sin distribución metamérica y que no es proporcional al desencadenante que lo produjo. Es más frecuente en mujeres en torno a 40-50 años sin predilección por raza y siendo típica la afectación de un único miembro (especialmente el miembro superior) Tiene una incidencia de hasta el 35% según la población estudiada.

No tiene una etiología clara, pero si se sabe que un evento desencadenante puede producir un arco reflejo modulado por centros corticales ocasionando alteraciones vasculares.

Clasificación:

- Tipo I: No existe lesión nerviosa. Supone un 90%.
- Tipo II: Existe una lesión nerviosa definida.

Ambos presentan mismos signos y síntomas.

DIAGNÓSTICO

No existe una prueba específica que haga diagnóstico de SDRC.

Clínico

Dolor difuso, hipersensibilidad cutánea, ardor, edema, atrofia muscular, rigidez articular, sudor anormal y cambios en la textura de la piel del área afecta pudiendo verse brillante y delgada. Todos estos cambios se producen típicamente tras un evento desencadenante como por ejemplo inmovilización, fracturas o intervenciones.

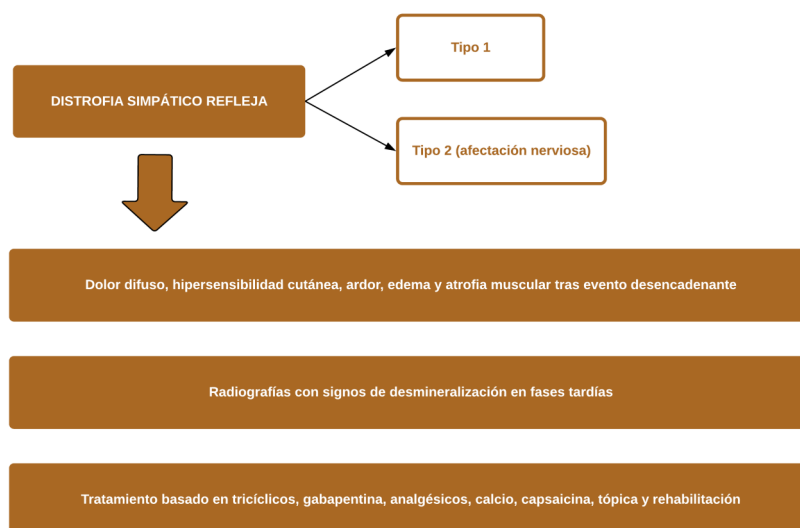
Se debe hacer un **diagnóstico diferencial** con otras patologías como pueden ser la trombosis venosa profunda, la tromboflebitis y celulitis, el linfedema, la insuficiencia vascular...

Pruebas Complementarias

- Radiografía: es más útil en fases tardías ya que se puede observar signos de desmineralizaciones.
- TAC: asimetría de flujo en las fases 1, 2 y/o 3
- Gammagrafía ósea: nos ayuda para realizar un diagnóstico precoz cuando todavía la radiografía es normal. Se observa un aumento de captación en la fase ósea.
- Las pruebas de laboratorio no nos suelen aportar información.

TRATAMIENTO

- Consenso de expertos recomienda la utilización de: Tricíclico (ejm. Amitriptilina) + anticonvulsivante (ej. Gabapentina) + AINE/ opioide.
- Otros fármacos utilizados: calcio, capsaicina tópica...
- Rehabilitación: derivar de forma preferente.



BIBLIOGRAFÍA

- Physiotherapy for pain and disability in adults with complex regional pain syndrome types I and II (Review). Smart KM, Wand BM, O'Connell NE. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 24;2.
- Complex regional pain syndrome in adults: UK guidelines for diagnosis, referral and management in primary and secondary care. London: RCP, 2018.